

23 - 05- Trouble Stress Post Traumatique (TSPT) - Pr. LAFFINTI

Nous continuons, chers étudiants, notre série de cours et nous terminons par un chapitre sur le trouble stress post-traumatique, anciennement appelé état de stress post-traumatique, et rebaptisé trouble stress post-traumatique par la cinquième version du manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux. Comme définition, le trouble stress post-traumatique correspond à un ensemble d'éléments cliniques organisés qui sont durables, dont la survenue est éventuellement différée, qui apparaissent dans la suite d'un événement objectivement traumatisant, durant lequel la personne s'est retrouvée confrontée soit à une mort réelle, que ce soit sa propre mort ou celle d'autrui, ou à la peur de mourir, ou à de graves blessures, entraînant chez cette personne une réaction de peur, d'impuissance et d'horreur. Il s'agit d'un sujet qui suscite de plus en plus d'intérêt, notamment sur le plan médiatique, en raison de la multiplication de nos jours de situations pouvant être traumatisantes sur le plan psychique.

C'est un trouble qui reste sous-diagnostiqué, parce qu'il y a une dimension de honte chez les patients qui les pousse à cacher ou à garder leurs symptômes, ou parfois par méconnaissance du caractère pathologique de leurs symptômes. Le trouble stress post-traumatique, comme j'ai cité plus haut, s'appelait état de stress post-traumatique, mais cette appellation a été revue en question par la version 5 du DSM, qui a séparé le trouble stress post-traumatique des troubles anxieux, donc c'est un trouble qui faisait partie des troubles anxieux, mais qui est désormais classé dans une catégorie à part appelée troubles liés à des traumatismes ou à des facteurs de stress. Sur les données épidémiologiques, on part d'une prévalence en population générale de 1%, cette prévalence passe à 7,8% sur une vie entière, et les femmes sont deux fois plus touchées par le TSPT par rapport aux hommes, la prévalence est plus élevée chez les populations qui sont exposées soit à des catastrophes, soit en période de conflits armés.

10% après la seconde guerre mondiale, 15 à 20% après la guerre du Vietnam, soit près d'un million de vétérans, et jusqu'à 40% des soldats américains sont diagnostiqués porteurs de stress post-traumatique au retour de la guerre en Irak. Dans l'étude clinique du trouble stress post-traumatique, nous allons voir l'événement traumatique, les réactions immédiates, l'état de stress aigu, la phase de latence et le trouble stress post-traumatique constitué. D'abord l'événement traumatique, il s'agit le plus souvent d'un événement exceptionnel qui va confronter la personne au réel de la mort, que ce soit une menace vitale pour la personne ou une mort effective d'autrui.

Cet événement est caractérisé par sa soudaineté, sa violence, son pouvoir destructeur et désorganisateur. Cet événement est aussi du domaine de l'incalculable, avec un effet de surprise sur une personne qui n'y est pas préparée. Cette personne n'arrive pas à nommer ou décrire cet événement, c'est de l'ordre de l'indécidable et de l'innombrable.

Cet événement traumatique peut être de différentes natures, comme des catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre, les inondations, les tsunamis, ça peut être aussi d'origine humaine comme des attentats terroristes. C'est aussi la période des guerres, des

bombardements, des génocides, etc. Elle peut aussi être en rapport avec des accidents graves, soit des accidents de la voie publique ou des accidents de la voie ferrée par exemple.

Ça peut aussi être une mort violente à laquelle la personne a été témoin. Ça peut être aussi des viols ou des agressions avec menace de mort ou des vols à l'arbre blanche. L'événement traumatique peut aussi être un moment bref dans une séquence plus longue, comme des personnes en captivité ou des personnes qui sont victimes de tortures ou de sévices répétés sur une longue période.

C'est parfois un moment bien particulier qui va faire le point de départ du traumatisme. Le point de départ du traumatisme peut aussi être une sommation d'événements insupportables comme des visions répétées d'horreur. Je cite certains métiers particuliers comme les sapeurs-pompiers, les agents de la police judiciaire ou la police scientifique, aussi les militaires en mission de maintien de paix dans des régions de conflits armés qui sont témoins de véritables scènes d'horreur à répétition.

L'événement traumatique brutal et violent va submerger la personne dans un état émotionnel très intense qui va durer quelques fractions de secondes qu'on appelle la réaction d'effroi. C'est un état très intense que la personne a du mal à décrire. C'est au-delà de la peur et de l'angoisse qui va laisser la personne complètement sidérée.

Cette imminence de la mort va secouer la personne, bien sûr, va ébranler son sentiment d'invulnérabilité. Rapidement et immédiatement après l'événement traumatique, la personne va présenter des réactions symptomatiques qu'on appelle des réactions immédiates-brèves. Ces réactions durent habituellement quelques minutes à quelques heures et ne dépassent pas les deux jours.

L'angoisse, l'anxiété, bien sûr, est au centre de ces réactions immédiates-brèves qui peuvent être des réactions adaptées et qui viennent du stress adapté et qui sont représentées par des manifestations anxieuses qui vont se traduire à la fois sur le plan psychique et physique, mais dont l'intensité reste très modérée. Elles ne vont pas entraîner de troubles de comportement et qui sont rapidement résolutifs. Parfois, aucune manifestation anxieuse immédiate n'est observée, comme si le choc avait été instantanément surmonté.

Cela ne veut pas dire que la personne est protégée d'un éventuel trouble stress post-traumatique ultérieur. Le plus souvent, on assiste à ce qu'on appelle des réactions de stress dépassé, qui sont des réactions pathologiques, qui peuvent être de différentes natures. Cela peut être une réaction de stupeur et de sédation avec une personne qui est complètement inhibée, immobile, sous l'effet du choc de l'événement traumatique, ou à l'inverse, la personne va avoir une réaction d'agitation improductive avec des mouvements automatiques sans but précis.

Le sujet submergé par la frayeur de mourir peut se trouver au contraire à une fuite panique sans

logique qui peut avoir des conséquences dramatiques. Dans ces réactions immédiates, on décrit souvent ce qu'on appelle une dissociation péri-traumatique, qui est un des symptômes importants et qui a aussi une valeur pronostique. Cette dissociation péri-traumatique correspond à une altération profonde de la perception du temps, du lieu et de soi-même, avec une impression de dépersonnalisation, une sensation de ne plus être soi-même, mais aussi une déréalisation, avec un sentiment de déréalité, comme si c'était dans un rêve.

Il y a aussi un trouble de la perception du temps avec un temps qui semble être au ralenti. Donc le patient vous décrit un temps qui se déroule vraiment au ralenti. Parmi les réactions immédiates, on peut trouver aussi des réactions de type agressif avec un comportement d'hétéro-agressivité, ça peut aussi être sous forme de troubles convertis, des accès hystériformes, il peut s'agir d'accès confuso-onérique ou d'accès d'allure maniaque, ou carrément des déclenchements psychotiques qui sont brefs.

Les réactions immédiates bref qu'on vient de voir durent habituellement moins de 48 heures. Mais les symptômes peuvent se prolonger et persister au-delà de 48 heures. Dans ce cas, le diagnostic retenu devient celui du trouble stress aigu, anciennement appelé état de stress aigu.

Pour retenir le diagnostic de trouble stress aigu, il faut que les symptômes surviennent dans les 4 semaines suivant l'événement traumatique. Soit en prolongeant les réactions immédiates avec continuité de la symptomatologie, soit après une certaine période de latence, donc les premières réactions immédiates se sont amendées en moins de 48 heures, mais les symptômes peuvent reprendre, mais toujours dans les 4 semaines suivant le traumatisme initial. Toujours pour le diagnostic de trouble stress aigu, il faut que la durée totale de la symptomatologie ne dépasse pas un mois.

Sur le plan clinique, le trouble stress aigu se manifeste par une symptomatologie clinique qui est proche du trouble stress post-traumatique qu'on va détailler plus tard, soit à la l'apparition de symptômes de réviviscence, de traumatisme, des conduites d'éclatement, une hyperactivité neuro-végétative, donc tout ça on va le revoir dans la clinique du trouble stress post-traumatique. Donc la symptomatologie totale ne doit pas dépasser un mois, mais il y a possibilité que les symptômes cliniques persistent au-delà d'un mois, donc si la symptomatologie persiste au-delà d'un mois, le diagnostic va être redressé en faveur d'un trouble stress post-traumatique proprement dit. La phase de latence, quant à elle, est une phase qui n'est pas constante.

Donc on vient de voir l'évolution de la symptomatologie peut-être d'un seul tenant depuis l'événement traumatique et jusqu'à l'installation du trouble stress post-traumatique. Mais il peut y avoir aussi une phase de latence entre les premières manifestations immédiates et l'installation du trouble stress post-traumatique. Cette phase de latence est de durée variable qui peut aller de quelques semaines à plusieurs années.

C'est une phase généralement de réorganisation et d'aménagement palliatif qui tente de contenir

l'effet de l'effraction traumatique. Certaines personnes vont surinvestir du côté professionnel, d'autres vont faire du travail associatif ou de la production artistique, etc. Parfois, cette phase de latence peut être indemne de toute symptomatologie, peut être silencieuse.

Mais souvent, si on l'analyse de façon rétrospective, on s'aperçoit que cette phase a été marquée par une symptomatologie de type phobique, par du repli affectif, par certains désinvestissements ou des conduites addictives ou par des troubles du sommeil. Nous arrivons à la clinique du trouble stress post-traumatique constitué. Ce trouble peut, comme on vient de le citer, prolonger un état de stress ou un trouble stress aigu.

Il peut s'agir d'une maladie de traumatisme chronique ou de traumatisme initial, qui est généralement intérieur à la maladie de la maladie de la maladie de l'AIDS. Il peut s'agir d'une maladie de trauma de la maladie de l'AIDS, ou d'une maladie de trauma de l'AIDS, ou d'une maladie d'une maladie de trauma de l'AIDS. rappeler le premier traumatisme.

Mais les patients, généralement, ne vont pas aller consulter rapidement et vont garder leurs symptômes pendant longtemps, soit parce qu'ils ont l'impression qu'on va mal les comprendre ou qu'on ne va pas comprendre leur souffrance, ou surtout à cause d'une dimension de honte et de culpabilité qui se voit souvent chez ces patients. Cette culpabilité qui peut se voir chez ce père de famille, par exemple, qui se sent coupable de la mort de sa famille lors d'un accident, c'est cette dimension de honte qui peut se voir chez un militaire dont les compagnons d'armes ont perdu leur vie sur le champ de bataille et lui se sent comme étant un lâche par rapport à eux, ou cette culpabilité qui peut se voir aussi chez une victime de viol qui se dit qu'il n'a pas pu se défendre de son agresseur, ainsi de suite, ce qui va amener à un retard diagnostique qui peut aller à plusieurs mois, voire des années. La symptomatologie clinique du trouble stress post-traumatique n'est pas univoque, mais peut prendre des aspects cliniques appartenant à différents tableaux psychiatriques, le plus spécifique, c'est ce qu'on appelle le syndrome de répétition traumatique qui est pathogénomique du trouble stress post-traumatique.

Ce syndrome de répétition traumatique est fait de réviviscence à l'état de veille et des cauchemars traumatiques. Les cauchemars traumatiques, premièrement, sont des cauchemars qui vont reproduire à l'identique la scène initiale du traumatisme avec la même intensité émotionnelle, le même vécu d'effroi, avec des réveils en état d'angoisse importante, parfois d'agitation ou de rage impuissante. Parfois, le contenu de ces cauchemars est un contenu plus parcellaire en lien avec l'agressivité, la mort, sans reproduire véritablement la première scène du premier traumatisme.

Et ce sont des cauchemars qui vont se répéter de façon très irrégulière, ça peut se répéter chaque jour ou plusieurs fois pendant la même nuit, comme ça peut être espacé de plusieurs semaines, plusieurs mois, laissant le patient dans cette appréhension de leur survenue qui est souvent angoissante. Ces cauchemars sont à l'origine du trouble de sommeil, soit le sujet est réveillé à la fois par ces cauchemars, soit les patients vont éviter d'aller au lit par peur de revivre

la même intensité traumatisante dans ces cauchemars. A côté des cauchemars traumatiques, le syndrome de répétition traumatique comprend aussi des réviviscences à l'état de veille.

Il s'agit de souvenirs forcés, répétitifs, de forme d'image, de pensée ou de perception qui vont rappeler le traumatisme initial et qui peuvent se produire soit de façon spontanée, qui vont envahir la pensée du sujet, qui vont avoir le même sentiment lors de l'événement traumatique initial, comme si cet événement va se reproduire et le patient va agir comme si l'événement s'est réellement produit, avec les mêmes attitudes, les mêmes gestes, le même état de stupeur, d'inhibition lors de l'événement initial, les mêmes angoisses, les mêmes réactions ou comportements automatiques qui peuvent se voir. Ces réviviscences, d'ailleurs, appelées aussi l'antidote, peuvent aussi être déclenchées par n'importe quel indice qui peut rappeler la situation traumatisante. Ça peut être une conversation, un lieu, un bruit, une odeur, une personne, donc tout ce qui peut rappeler l'événement initial peut déclencher ces réviviscences déhures.

A côté du syndrome de répétition traumatique, les patients présentent aussi un état d'hypervigilance. Les patients se sentent toujours sur le qui-vive, dans un état d'alerte permanent, comme s'ils anticipent une nouvelle rencontre avec l'éminence de la mort, avec des réactions de sur-faux aux moindres stimulus. On trouve aussi sur le plan symptomatique des conduites d'évitement et un émoussement affectif, avec un désintérêt et un repli sur soi, donc le sujet va renoncer à certaines activités pouvant éventuellement rappeler le traumatisme, avec un certain détachement des affects, ce qui va limiter sur le plan relationnel les contacts du sujet.

Aussi, on trouve une hyperréactivité non-végétative marquée par une irritabilité, surtout avec des accès de colère, mais aussi une angoisse paroxystique dans les situations rappelant le traumatisme avec les manifestations habituelles de l'angoisse, l'attaque icardie, la gêne respiratoire, ainsi de suite. Aussi, la clinique peut être faite de troubles cognitifs, notamment des difficultés de concentration et des difficultés immunologiques. D'autres manifestations cliniques peuvent se voir, ils ne sont pas spécifiques, mais qui peuvent compléter le tableau du trouble stress post-traumatique.

C'est essentiellement des manifestations anxieuses de type symptômes phobiques, des comportements d'évitement. Il y a aussi une dimension dépressive qui est quasi constante, avec une tristesse, une ébonie, parfois une culpabilité, qui peut évoluer vers un véritable épisode dépressif caractérisé. On peut trouver aussi des troubles de conduite de toutes sortes, notamment des conduites d'échec, de conduite de rupture, de prise de risque, conduite, par exemple, conduite à risque, des conduites addictives qui sont très fréquentes avec le recours aux substances psychoactives, notamment l'alcool, chez ces personnes traumatisées crâniennes.

Mais aussi, il peut y avoir un remaniement de la personnalité qui va s'opérer chez ces sujets traumatisés, donc avec tendance à la régression, avec dépendance vis-à-vis de l'entourage, avec recherche de sécurité, mais aussi des exigences capricieuses et des revendications de considération et de réparation d'un préjudice lié au traumatisme. Après la clinique, certaines

formes cliniques sont décrites comme des formes frustes, formes sévères, des formes tardives si la symptomatologie survient après six mois de l'événement, mais surtout les formes de l'enfant et de l'adolescent dont la symptomatologie peut être un peu populaire, notamment chez les enfants, où la symptomatologie clinique peut se traduire par des difficultés d'apprentissage scolaire, par une perte des acquis, ou par des rêves effrayants, ou parfois par des jeux répétitifs ou des dessins en lien avec le traumatisme. Chez l'adolescent, la clinique peut se manifester par des accès de colère, par de l'impulsivité ou par des troubles des conduites alimentaires.

Le diagnostic positif du stress post-traumatique est un diagnostic clinique qui nécessite une recherche active de la symptomatologie, notamment chez les patients à risque, donc il faut toujours poser la question sur l'éventualité d'être exposé à un événement traumatisant, et essayer d'établir une relation de confiance avec son patient dans une ambiance sécurisante et d'écoute empathique pour amener le patient à évoquer ses symptômes liés au traumatisme. Donc le diagnostic clinique positif sera retenu dans l'existence du syndrome de répétition traumatique avec tous les signes associés. Concernant les critères du DSM-5, ce sont des critères assez nombreux, donc ils sont réservés au cadre de la recherche.

Concernant le diagnostic différentiel, le diagnostic différentiel du trouble stress post-traumatique se fait d'abord avec le trouble stress aigu. C'est plus une question de durée de symptômes, donc si la symptomatologie se prolonge au-delà d'un mois, c'est un trouble stress post-traumatique, mais la clinique peut être similaire pour les deux entités. Deuxièmement, le diagnostic différentiel se fait aussi avec le trouble de l'adaptation qui est marqué par des manifestations anxieuses, dépressives ou par des troubles du comportement et des conduites qui surviennent suite à une situation, un événement stressant, mais qui n'a pas le caractère exceptionnellement menaçant ou objectivement traumatisant.

Ces symptômes généralement rentrent dans l'ordre une fois la situation ou l'événement stressant est éliminé. Le trouble stress post-traumatique est indifférencié aussi du syndrome subjectif des traumatismes crâniens qui se traduit par des symptômes de défalé, de vertiges, par des troubles caractériels et une tendance aux revendications qui se voit chez les patients ayant eu un traumatisme crânien. Le trouble obsessionnel compulsif est aussi un diagnostic différentiel par rapport à ces souvenirs forcés liés au traumatisme qui peuvent prêter confusion avec une pensée obsessionnelle.

Les souvenirs forcés sont aussi indifférenciés des hallucinations intra-psychiques qui se voient dans un autre cadre du trouble psychiatrique dans le cadre des psychoses. L'évolution du trouble stress post-traumatique est variable, elle est souvent favorable avec régression complète de la traumatologie dans la plupart des cas, mais elle peut être aussi défavorable, voire chronique avec des complications de type modification du caractère, de type complication dépressive avec un risque suicidaire très important chez les patients ayant subi un traumatisme crânien. Les conduites suicidaires ne sont pas rares chez ces patients-là et aussi il peut y avoir des complications de type repli social, des insertions socio-professionnelles avec un attentisme

majeur sur la qualité de vie des patients.

Nous arrivons au chapitre de la prise en charge, donc cette prise en charge peut être déclinée en une intervention précoce qui se fait dans l'essuie du traumatisme dont l'objectif sera de reconnaître la détresse des victimes, de soulager leur souffrance, c'est une sorte de secourisme psychologique qui peut se faire généralement au niveau des services d'accueil des urgences de l'hôpital ou parfois même sur le terrain où il s'est produit l'événement traumatique. Cette intervention précoce des soins post-immédiat appelé débriefing peut être réalisée vers le deuxième, troisième jour, ça peut être de façon individuelle ou collective, elle est destinée aux victimes mais aussi aux sauveteurs des victimes, donc c'est un soin qui permet la verbalisation de l'expérience traumatisante, notamment le déroulement, les pensées, les émotions ressenties à ce moment-là afin de pouvoir leur donner un sens et de les intégrer dans l'histoire personnelle du sujet. C'est aussi un temps pour informer le patient ou les victimes de l'éventuelle évolution des troubles vers un état de stress post-traumatique, sans effet préventif et discuté, donc pour certains auteurs ce débriefing aurait un effet préventif pour d'autres, donc il n'a pas d'effet préventif sur l'éventuelle apparition d'un trouble stress post-traumatique par la suite.

Pour le traitement du trouble stress post-traumatique constitué, donc c'est une prise en charge qui se fait généralement en ambulatoire, donc l'hospitalisation est réservée aux formes sévères, donc en cas de risque suicidaire ou en cas de comorbidité importante nécessitant une prise en charge hospitalière. Cette prise en charge fait appel à des volets pharmacologiques et psychothérapeutiques pour les médicaments. Premièrement, c'est essentiellement des antidépresseurs qui sont considérés comme le traitement de première intention du choix dans l'état de stress ou le trouble stress post-traumatique.

Ils ont une indication spécifique pour ce trouble avec une efficacité qui est démontrée notamment sur la composante anxieuse et dépressive associée au trouble stress post-traumatique. On peut utiliser différents molécules, surtout les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine qui sont indiqués dans ce trouble. La durée du traitement est de 12 mois minimum.

Pour les autres médicaments, ils ont une action adjuvante aux antidépresseurs, notamment les anxiolytiques. On peut utiliser des molécules benzodiazépiniques pour soulager une anxiété importante en aiguë, mais on leur préfère de l'hydroxyzine, la taraxe, en courte durée, notamment en les périodes de porte-angoisse. Pour les antipsychotiques, notamment des neuroleptiques classiques, comme le noleptil en goutte ou l'alévomépromazine, le nozinon, soit en goutte ou en comprimé, ils ont une certaine action sur les cauchemars traumatiques et sur les troubles du sommeil associés aux cauchemars traumatiques.

On peut prescrire 3, 5 ou 5 jusqu'à 10 gouttes le soir de chaque médicament. Autres médicaments indiqués, surtout les bloqueurs adrénergiques, comme le paracetamol ou le propranolol, qui est un méta-bloquant, a la pathologie d'un demi-air incomprimé en courte durée, qui a un effet sur les symptômes d'hyperréactivité neuro-végétative liés aux troubles de stress

post-traumatique. La prazosine est un alpha-bloquant.

Il aurait un intérêt sur les cauchemars traumatiques, mais c'est un médicament qui n'est pas commercialisé au Maroc. Le deuxième volet de la prise en charge du trouble stress post-traumatique est le volet psychothérapeutique. L'association des deux volets serait préférable avec des effets combinés à la fois de la pharmacothérapie et de la psychothérapie.

Les techniques utilisées en psychothérapie du trouble stress post-traumatique sont les thérapies cognitives et comportementales. Ils vont utiliser des techniques comme l'exposition d'abord en imagination, où le patient va se représenter des éléments de plus en plus anxiogènes liés au traumatisme de façon graduelle, ou suivi d'une exposition in vivo, c'est-à-dire une fois le patient sécurisé par l'exposition en imagination, il va affronter graduellement les objets anxiogènes rappelant le traumatisme. Les techniques de désensibilisation systématique associées à la relaxation et l'apprentissage prise des réponses neuro-vegétatives excessives.

La relaxation, la restructuration cognitive va viser les idées ou les pensées négatives surtout comme la honte et la culpabilité. Une autre technique développée récemment, il y a quelques trentaines d'années est l'EMDR. C'est une technique qui utilise les mouvements oculaires pour atténuer l'effet du traumatisme.

C'est une technique psychothérapeutique qui associe aussi des techniques de TCC, d'exposition de restructuration cognitive associée à des mouvements face à des yeux qui vont permettre lors des pensées anxiogènes pour diminuer l'intensité de la détresse liée au traumatisme. D'autres techniques d'hypnothérapie sont également proposées. Un autre élément de la prise en charge qui est aussi important est la question de la réparation.

Notamment en cas d'accident lié au travail ou dans le cas des traumatismes de guerre pour les soldats. La question de la reconnaissance et de la réparation matérielle est aussi un élément important de la prise en charge et permet aussi de potentialiser l'effet des traitements proposés. En conclusion, le stress post-traumatique reste un sujet d'actualité.

Le diagnostic nécessite une application importante de la part du médecin. Les traitements proposés actuellement permettent une amélioration de la symptomatologie dans la plupart des cas. Cependant, certaines formes sévères ou compliquées posent toujours des problèmes de prise en charge et nécessitent une attention plus particulière.

Je vous remercie.